



NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 Semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR:

Torsión Testicular

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

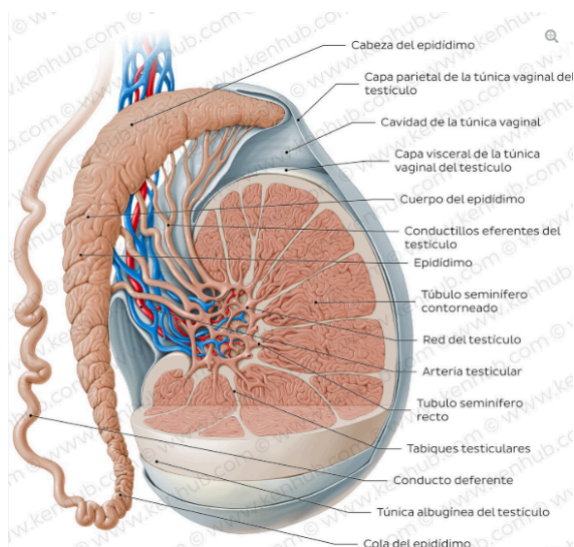
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN)

La torsión testicular es una emergencia médica en la cuál el cordón espermático, que suministra sangre a los testículos, se tuerce, interrumpiendo el flujo sanguíneo hacia el testículo afectado, si no se trata rápidamente, puede llevar a la pérdida del testículo por falta de oxígeno y nutrientes, por lo tanto el objetivo quirúrgico de la torsión testicular es restaurar el flujo sanguíneo al testículo afectado lo antes posible para preservar la viabilidad del tejido y evitar necrosis testicular.

1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN).

ANATOMÍA





Los testículos son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6cm de longitud y con un peso de 10-15 gramos.

El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro (usualmente el izquierdo). Los testículos están suspendidos dentro del escroto por el cordón espermático.

Capas del testículo

- Piel o escroto
- Dartos
- Capa celular subcutánea
- Fascia espermática externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermática interna
- Túnica vaginal del testículo



Conductos espermáticos

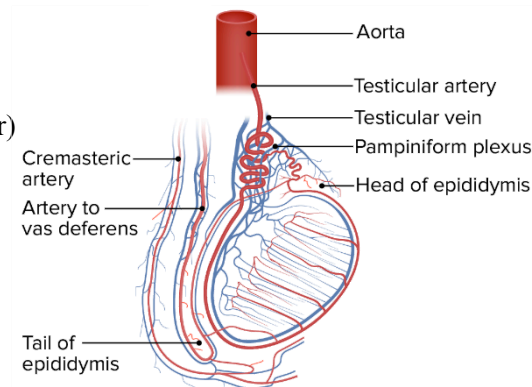
- Conductillos eferentes: Expulsan a los espermatozoides al conducto epidídimo
- Conducto del epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides
- Conducto deferente: Involucrado en el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Irrigación y drenaje venoso

- Arteria testicular
- Arteria cremastérica (rama de la arteria epigástrica inferior)
- Arteria del conducto deferente (rama de la arteria vesical inferior)
- Plexo pampiniforme y la vena testicular

Inervación

- Plexo testicular



FISIOLOGIA

Los testículos producen y almacenan las células germinales masculinas (espermatozoides) y secretan hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos (principalmente testosterona)



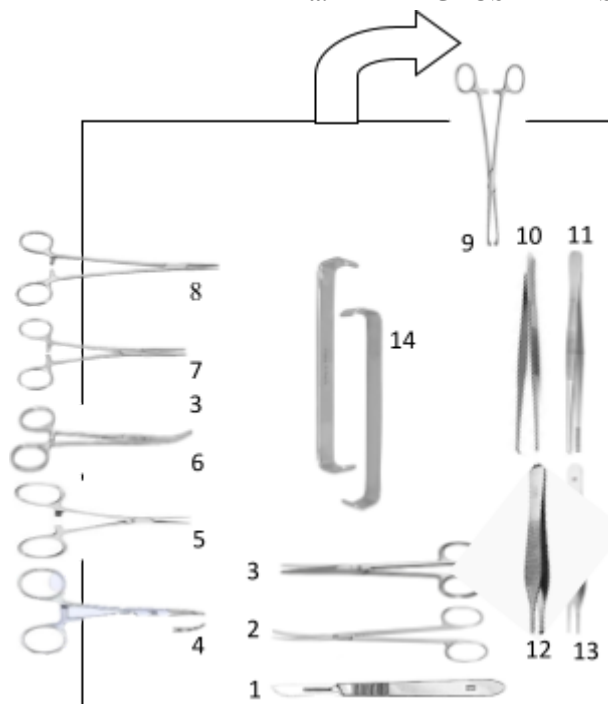
1.3. LISTA DE CHEQUEO:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS 😊	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de Plastia	● Paquete de ropa general ● Gasa ● Compresas ● Torundas ● Apósitos ● Hoja de bisturí #15 ● Aseptojeringa ● Caucho de succión ● Guantes ● Electrobisturí ● Vessel loops	TCS: Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ circulo redonda de 27 mm. Fascia y musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con ½ circulo redonda de 37 mm. Fijación al escroto: Polipropileno 4/0, 5/0 o 6/0 con aguja ½ circulo redonda Escroto: Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda	Solución Salina

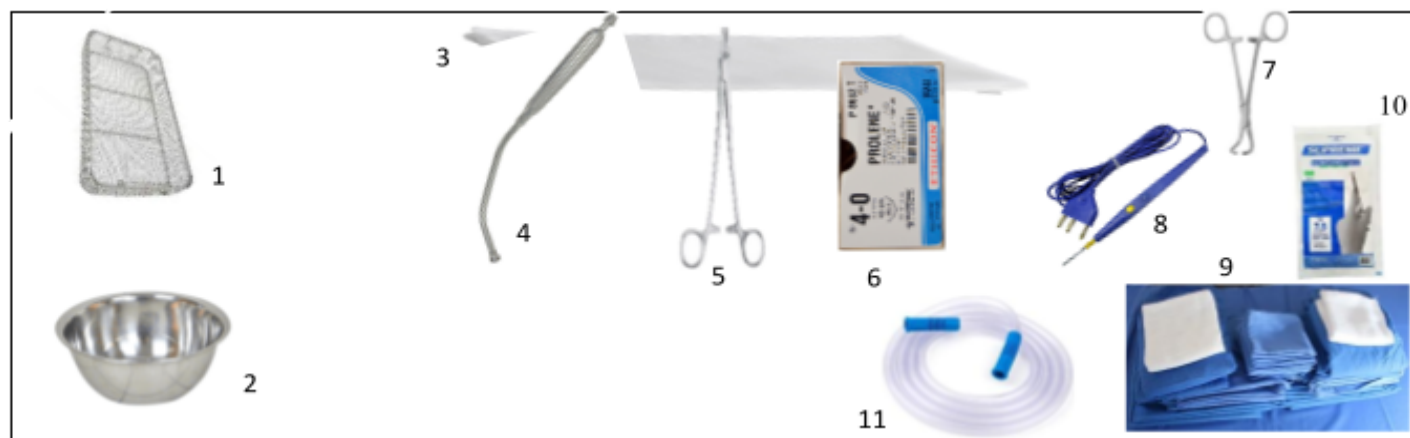


2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

a. ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).



- Mango de Bisturí 3, Hoja 15
- Tijeras de Metzembraum
- Tijeras de Mayo rectas
- Pinzas Baby Mosquito Curvas
- Pinzas Baby Mosquito Rectas
- Pinzas Kelly Curvas
- Pinzas Kelly Rectas
- Pinzas Kelly Adson
- Pinza Alix
- Pinza de Disección Con Garra
- Pinza de Disección Sin Garra
- Pinza de Disección Adson con Garra
- Pinza de Disección Adson sin Garra
- Separadores de Farabeuf



1. Canasta de Plastia. 2. Coca con Suero. 3. Compresa. 4. Cánula de Yankawer. 5. Portaagujas. 6. Suturas. 7. Pinza de Campo Backhouse. 8. Lapicero del electro. 9. Paquete de Ropa. 10. Guantes. 11. Caucho de Succión.



2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

Decúbito Supino



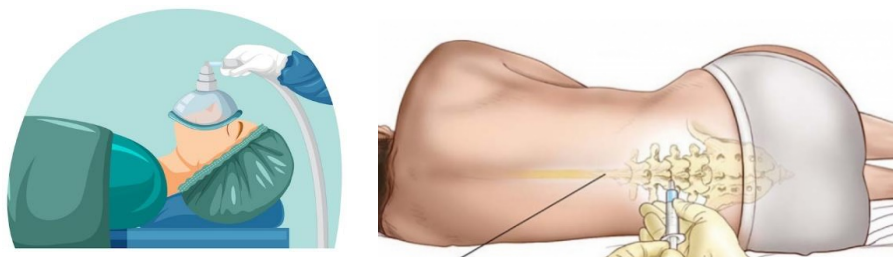
2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):





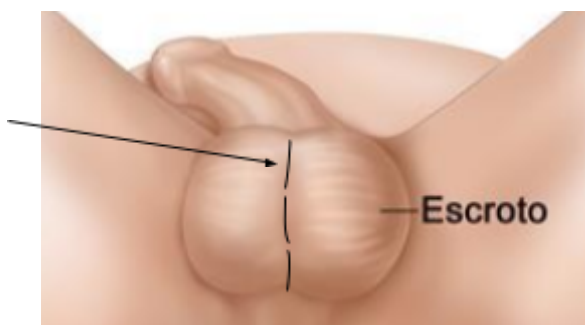
3. ETAPA DE EJECUCION:

- a) ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA): Anestesia General o Raquídea.



- b) INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):

**Incisión escrotal
siguiendo el pliegue**



- c) PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión escrotal anterior siguiendo el pliegue	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15
Toma de la túnica vaginal e incisión	Pinza Mosquito curva Tijeras de Plastia
Se libera el testículo del escroto y reducción de la torsión testicular	Gasas húmedas tibias
Se observa el color, si es oscuro y líquido sanguinolento, se reseca el testículo	Tijeras de Metzembraum
Se fija el cordón espermático al escroto	Porta agujas fino Pinza de disección adson sin garra Polipropileno 4/0 5/0 o 6/0 aguja ½ circulo redonda
Se hace cierre de las capas del escroto y se realiza curación	Portaagujas fino Pinza de disección adson sin garra



Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo
redonda

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____